FACULTE DE MEDECINE DE BEJAIA

LA BIOETHIQUE

Module Santé Société Humanité

1ère année Médecine

Année 2019 / 2020

Docteur S.GANI

LA REFLEXION BIOETHIQUE

I/ INTRODUCTION

Les avancées de la science dans le domaine du vivant suscitent des inquiétudes concernant le devenir de l'homme et de l'humanité nécessitant une réflexion éthique.

Le 19 octobre 2005, la Conférence générale de l'UNESCO, réunie en sa 33e session, a adopté la ***Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme***. Ce texte énonce un ensemble de principes de bioéthique arrêtés d'un commun accord par les 191 états membres de l'UNESCO.

Définition

Le terme a été prononcé pour la première fois en 1970 par Van Rensselaer Potter qui a formé le mot bioéthique en associant deux mots grecs : ***bios*** (la vie, représentant la réalité du vivant et les sciences de la vie) et ***éthos*** (qui renvoie à des valeurs et des devoirs).

L'art.354 de la loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé, définit la bioéthique comme « **l'ensemble des mesures liées aux activités relatives à la transplantation et à la greffe d'organes, de tissus et de cellules, au don et à l'utilisation du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance médicale à la procréation et à la recherche biomédicale**.»

La **bioéthique** est l'étude des questions et des problèmes moraux qui peuvent apparaitre à l' occasion de pratiques médicales nouvelles impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de recherches en biologie.

La bioéthique est à la fois une réflexion sur les problèmes moraux liés à la recherche sur le vivant et à ses applications ainsi qu'un guide de conduite des professionnels et des usagers du système de santé.

La recherche d'éléments permettant de tracer les frontières du permis et de l'interdit en matière de recherche médicale constitue le socle de la réflexion bioéthique.

La bioéthique dépasse l'éthique médicale et s'ouvre aux non médecins : législateur, théologien, philosophe, représentant de la société civile. Elle concerne l'ensemble des citoyens.

II/ HISTOIRE DE LA REFLEXION BIOETHIQUE

Le 09 Décembre 1946, à Nuremberg s'ouvre le procès des médecins allemands. Il se termine le 19 Juillet 1947.

L'accusation met en évidence l'atrocité des expérimentations médicales réalisées sur des êtres humains dans les camps de concentration.

- Les questions d'ordre éthique soulevées par les experts médicaux et les réponses qu'ils ont apporté aux arguments des accusés et de leurs avocats constituent une réflexion qui est à l' origine du code de Nuremberg considéré comme le texte fondateur de la bioéthique.
- Le code de Nuremberg définit les « **principes fondamentaux qui devraient être observés pour satisfaire aux concepts moraux, éthiques et légaux devant encadrer toute expérimentation clinique menée sur l'homme** » ;
  Ils se résument en dix points :

- **Le consentement du sujet humain est absolument essentiel.**
- **L'expérimentation doit conduire à des résultats pour le bien da la société.**
- **L'expérimentation doit être basée sur les résultats issus d'expériences sur animaux.**
- **L'expérimentation doit éviter toute souffrance physique et mentale inutile.**
- **Aucune expérience ne peut être conduite si on pense que la mort ou une infirmité peut en découler.**

- **Le degré de risque pris en compte ne doit pas excéder celui déterminé par l'importance humanitaire du problème à résoudre par l'expérience.**
- **Toutes les précautions doivent être prises pour le sujet.**
- **L'expérience ne peut être conduite que par des personnes qualifiées.**
- **Le sujet doit avoir la liberté d'interrompre sa participation à l'expérimentation.**
- **Durant le cours de l'expérimentation, l'investigateur doit pouvoir en âme et conscience, retirer un sujet de l'expérimentation s'il juge que l'expérimentation peut provoquer des conséquences dommageables pour ce sujet.**

Ce code dont la portée historique est fondamentale définit la légitimité des expériences médicales et le statut des personnes participant à une expérimentation ; il annonce ainsi la naissance de la bioéthique moderne

Outre la découverte des crimes nazis, d'autres évènements traumatisants ont fait réagir l'opinion publique et ont provoqué une mise en cause des recherches médicales :

- **Inoculation du virus de l'hépatite A** à des enfants handicapés mentaux (1956/1970 Willowbrook State School).
- **Le scandale de Tuskegee (1932-1972) :** recherche longitudinale sur la syphilis menée sur 399 ouvriers noirs et pauvres à Tuskedee en Alabama, laissés sans soins pendant plus de 30 ans, sans les informer de leur état, révélé à la presse (New York Times) en 1970 par un des médecins participant à la recherche. Ce scandale a entrainé un procès et des dédommagements pour les derniers survivants. (Rapport de Belmont)
- **Le scandale du valproate de sodium** contenu dans le médicament Dépakine (antiépileptique du laboratoire SANOFI) et accusé de provoquer des malformations, des retards intellectuels ou des cas d'autismes chez les enfants exposés et les nouveau-nés. Selon l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 14322 femmes enceintes y ont été exposées entre 2007 et 2014.
- **La déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme** de l'UNESCO énonce 15 principes de bioéthique :

  1/ Dignité humaine et droits de l'homme
  2/ Effets bénéfiques et effets nocifs
  3/ Autonomie et responsabilité individuelle
  4/ Consentement
  5/ Personnes incapables d'exprimer leur consentement
  6/ Respect de la vulnérabilité humaine et de l'intégrité personnelle
  7/ Vie privée et confidentialité
  8/ Egalité, justice et équité
  9/ Non-discrimination et non-stigmatisation
  10/ Respect de la diversité culturelle et du pluralisme
  11/ Solidarité et coopération
  12/ Responsabilité sociale et santé
  13/ Partage des bienfaits
  14/ Protection des générations futures
  15/ Protection de l'environnement, de la biosphère et de la biodiversité.

➢ **La déclaration d'Helsinki** a été adoptée en 1964 par l'association médicale mondiale. Elle a réaffirmé les grands principes applicables à la recherche clinique.

- Mais c'est en 1975 que cette association élargit cette déclaration à la recherche biomédicale sur l'être humain.
- Elle préconise que tout protocole de recherche portant sur un être humain devra être soumis à consultation d'un comité ad-hoc indépendant pour avis et conseils.
- Que ce protocole devra toujours contenir une déclaration sur les considérations éthiques impliquées dans cette recherche et devra indiquer que les principes énoncés dans la présente déclaration sont respectés.

Quelles sont ses recommandations :

- ✓ L'expérimentation doit avoir été préalablement réalisée en laboratoire et sur l'animal.
- ✓ **L'expérimentation doit faire l'objet d'un protocole expérimental à soumettre à un comité de lecture.**
- ✓ Les personnes qui effectuent les recherches doivent être qualifiées.
- ✓ Le but visé doit être en rapport avec le risque encouru par le sujet.
- ✓ Les risques et les avantages prévisibles pour le sujet doivent être évalués.
- ✓ Le respect de l'intégrité de la vie privée doit être garanti.
- ✓ Les risques potentiels doivent être mesurés.
- ✓ Le respect de l'exactitude des résultats en cas de publication doit être garanti.
- ✓ Le sujet doit être informé avant sa participation à la recherche.
- ✓ L'obtention du consentement éclairé du sujet est obligatoire.
- ✓ L'obtention du consentement éclairé du sujet mineur auprès de son représentant légal est obligatoire.
- ✓ La recherche doit répondre à un objectif acceptable sur le plan éthique.

Les progrès rapides des sciences médicales et biologiques ont imposé des interrogations et ont motivé la mise en place de comités nationaux d'éthique.

Le comité national d'éthique :

C'est un comité consultatif, il a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans le domaine de la biologie et de la médecine.
En ALGERIE, on l'appelle: **Le conseil national de l'éthique des sciences de la santé**
Il a été créé le 31 Juillet 1990 et installé par monsieur le ministre de la santé et de la population le 13 Octobre 1996.

Il est composé de :

- ✓ 01 représentant du ministère de la santé
- ✓ 09 professeurs en sciences médicales
- ✓ 03 praticiens de la santé
- ✓ 01 représentant du ministère de la justice
- ✓ 01 représentant du conseil supérieur islamique
- ✓ 01 représentant du conseil national de déontologie médicale
- ✓ 01 représentant du ministère de la défense
- ✓ 01 représentant du ministère du travail et de la protection sociale
- ✓ 02 représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

III/ QUELQUES PROBLEMES MORAUX LIES A LA BIOMEDECINE

1/ **Les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie**

Il s'agit de soins qui visent à soulager les douleurs physiques et la souffrance psychologique, morale et spirituelle dans le but de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort, pour les personnes en phase évoluée ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle.
C'est des soins qui améliorent le confort et la relation et qui soulagent les symptômes, permettant au patient de vivre non pas « malgré », mais « avec » sa maladie jusqu'à la fin de ses jours.
Le positionnement éthique, dans ce cas, est le refus de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie.

2/ **L'euthanasie**

Etymologiquement vient du grec « eu » (bien) et « thanatos » (mort), euthanasie veut alors dire « bonne mort » ou « mort douce ».
Il s'agit d'une mort provoquée par la main humaine avec l'intention d'abréger les souffrances du malade dans les cas où il n'y a plus d'espoir de guérison et où il souffre énormément. Il existe trois cas :

- L'euthanasie proprement dite ou euthanasie active : consiste en l'administration d'une médication mortelle, par une tierce personne, à un malade qui subit de grandes souffrances et qui est condamné.
- Le « suicide assisté » lorsque la tierce personne ne fait que fournir la médication au malade qui se donne lui-même la mort.
- L' « euthanasie passive » qui désigne l'arrêt des soins administrés à ce genre de malade, dans la mesure où l'on sait que cet arrêt des soins entrainera plus rapidement sa mort.

En Algérie, la loi sanitaire n'aborde pas ce sujet, cependant, **selon l'éthique musulmane, l'administration d'une substance mortelle au malade est interdite** (car la vie humaine est sacrée) ; l'euthanasie est considérée comme un homicide prémédité.
La loi n'autorise pas de droit à l'assistance au suicide, ni à l'euthanasie.

3/ **Don et transplantation d'organes**

Une greffe ou **une transplantation** est une opération chirurgicale consistant à remplacer un organe malade par un organe sain, appelé « greffon » ou « transplant » et provenant d'un donneur.
Le greffon peut être prélevé sur le vivant ou sur le mort.
La **constatation légale** de la mort est fondée sur : l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les reflexes du tronc cérébral et l'absence totale de ventilation spontanée.
La **mort encéphalique** ou mort cérébrale est définie comme la destruction irréversible et isolée des centres nerveux intracrâniens (2 EEG de 30mn chacun à 4 heures d'intervalle ou artériographie). Les personnes sont maintenues en état de mort cérébrale sous respiration artificielle, lorsque le cœur continue à battre spontanément, ce qui permet de maintenir les organes en bon état en vue de prélèvement.
La transplantation d'organes repose sur trois grands principes éthiques :

- Le consentement libre et éclairé du donneur : le donneur peut à tout moment retirer son consentement sans aucune formalité.
- L'anonymat : il est interdit, de révéler l'identité du donneur décédé au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.
- La gratuité du don : le corps est inviolable et hors commerce.

En Algérie, les articles 355 à 366 de la loi relative à la santé de 2018, règlementent la pratique de la transplantation d'organes et de tissus :

-le prélèvement, la transplantation d'organes, de tissus et de cellules humains, ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou de diagnostics, à partir de donneurs vivants apparentés compatibles avec le receveur.

-le donneur doit avoir la qualité de père, mère, frère, sœur, fils, fille, grand-mère, grand-père, oncle, tante, cousin ou cousin germain, neveu, nièce, conjoint, conjoint du père ou de la mère du receveur.
Toutefois, en cas d'incompatibilité immunologique, le recours au don croisé d'organes consistant à former deux paires « donneur/receveur » compatibles, peut être proposé aux donneurs et aux receveurs potentiels.

-le donneur doit exprimer son consentement au don devant le président du tribunal ; il peut à tout moment retirer son consentement sans aucune formalité.

-un comité d'experts délivre l'autorisation de prélèvement après s'être assuré que le consentement du donneur est libre et éclairé.
-il est interdit de procéder au prélèvement d'organes…sur des personnes vivantes mineures ou incapables ou sur des personnes vivantes atteintes de maladies de nature à affecter la santé du donneur ou du receveur.
-le prélèvement d'organes…à partir de personnes décédées ne peut se faire qu'après constatation médicale et légale du décès et si la personne n'a pas fait connaitre de son vivant, son refus (n'importe quel moyen, registre des refus tenu par l'agence nationale des greffes, les membres adultes de la famille).
-le consentement du receveur est exprimé en présence du médecin chef du service où il est admis et de deux témoins, après qu'il ait été informé par le médecin traitant des risques médicaux encourus
-le prélèvement ou la transplantation d'organes…ne peuvent être effectués que dans des établissements hospitaliers publics autorisés par le ministre chargé de la santé après avis de l'agence nationale des greffes.
-le prélèvement et la transplantation d'organes…ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction financière.

4/ La procréation médicalement assistée (PMA)

L'assistance médicale à la procréation est une activité médicale qui, en cas d'infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel.
Elle consiste en des pratiques cliniques, biologiques et thérapeutiques permettant la stimulation de l'ovulation, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle.(art.370 loi relative à la santé)

Elle a pour finalité de créer un être vivant humain grâce à une assistance médicale scientifique.
Les techniques de procréation (artificielles) sont nombreuses : insémination artificielle, fécondation in vitro, injection intra cytoplasmique du spermatozoïde.
Moments importants : - 1978 : naissance de Louise Brown, 1er premier bébé éprouvette en Angleterre née par FIV (fécondation in-vitro qui se fait hors du corps humain, en laboratoire, pour traiter l'infertilité) et l'embryon est ensuite implanté dans l'utérus de la femme (intervention d'un tiers dans la procréation qui est le corps médical).

- 1992 : mise au point de l'injection directe du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte en Belgique (ICSI : intracytoplasmic sperm injection).
- DPI : diagnostic préimplantatoire, sur l'embryon in vitro avant de l'implanter dans l'utérus, permettant d'identifier des gènes responsables de maladies graves (Trisomie 21, mucoviscidose …). Seuls les embryons sains sont transférés.

- De 0 à 60 jours : embryon
- Après 60 jours : fœtus
- A 6-7 jours : nidification dans l'utérus ; présence de cellules souches embryonnaires
- A 14 jours : apparition de la ligne primitive (ébauche de système nerveux (sensibilité possible)
- Jusqu'à 14 jours : pré-embryon pour les bio éthiciens

Position de la religion

Pour l'islam, l'insémination artificielle et la F.I.V sont permis, mais seulement si le couple est hétérosexuel, marié, et que le sperme permettant la fécondation provient du conjoint

Aspect juridique et éthique

La PMA soigne la stérilité des couples et non celle des individus ; elle répond à une demande thérapeutique et non à une convenance.

Les lois de bioéthique imposent des limites aux pratiques de PMA;

En résumé ces lois énoncent que :

1- La stérilité du couple doit être constatée.
2- Le couple doit recevoir une information complète, donc doit être bien éclairé,
3- Le couple doit donner son consentement pour tous les actes.
4- L'utilisation des gamètes pour la conception in-vitro est réservé à la finalité thérapeutique et non à la recherche ou à la commercialisation.
5- Les recherches sur l'embryon sont interdites : car les manipulations génétiques portent atteinte aux potentialités du génome, du sexe et de leur destinée.

6-Ne pas utiliser de mère porteuse ou maternité de substitution (femme qui prête ou loue son utérus à un couple).
ll existe deux cas:

- **La procréation pour autrui:** la mère porteuse est inséminée artificiellement avec le sperme du père.
- **La gestation pour autrui:** la mère porteuse porte un embryon produit par FIV à partir des gamètes du couple.

A la naissance, l'enfant est remis au couple demandeur.
Mais est ce que la mère porteuse peut décider de garder l'enfant ?
Et si l'enfant nait malformé, qui voudra de l'enfant ?

Législation

En Algérie, les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation se trouvent dans la loi n°18-11 du 2juillet 2018 relative à la santé dans les articles 370 à 376.

- Couple vivant légalement marié, souffrant d'infertilité avérée ; il ne doit être recouru qu'aux spermatozoïdes de l'époux et à l'ovule de l'épouse à l'exclusion de toute autre personne.
- Sont interdits, la manipulation dans un but de recherche scientifique, le don, la vente et toutes autres formes de transaction : de spermatozoïdes, d'ovocytes (même entre coépouses), d'embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou une autre femme (sœur, mère, ou fille), de cytoplasme.

5/ Le statut de l'embryon

L'embryon a un statut particulier de personne humaine potentielle ou en devenir.
Pour l'islam et le catholicisme, l'embryon est une personne dès la conception.
Pour les scientifiques, l'embryon in vitro est un pré embryon (blastocyte, amas de cellules) tant qu'il n'est pas implanté dans l'utérus. C'est la nidification qui en fait un embryon.

CONCLUSION

L'intégrité morale et intellectuelle est difficile à définir.
La science n' est ni bonne ni mauvaise en soi : elle n' est que ce que les hommes en font.